**BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN**

**PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG**

# QUY TRÌNH CHĂM SÓC BỆNH VIÊM TAI THANH DỊCH

Mã đề xuất CS-TMH-09; bản trình thẩm định 14/10/2026. Chưa ban hành. Biên soạn/thẩm định/phê duyệt: ……

Áp dụng chăm sóc điều dưỡng theo bệnh, gồm nhận định, chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá. Kỹ thuật xâm lấn phải có quy trình riêng theo QĐ3023, chỉ định và người đủ phạm vi/năng lực; bộ này không cho phép điều dưỡng tự chẩn đoán hoặc quyết định điều trị.

ICD: H65.0

## 1. Nhận định

Xác nhận hai định danh, lý do đến khám, khởi phát, bệnh nền, thuốc/dị ứng; đánh giá ABCDE, sinh hiệu, đau, ăn/nuốt, dịch vào-ra và nguy cơ té ngã theo tình trạng. Báo ngay khi khó thở, thở rít, tím, giảm ý thức, chảy máu nhiều hoặc dấu giảm tưới máu. Cận lâm sàng theo bác sĩ.

- Hỏi bệnh:

+ Người bệnh có sổ mũi, nghẹt mũi không?

+ Đau nhức tai, sốt không?

+ Mức độ đau nhiều không?

+ Thấy tai có chảy mủ ra không?

+ Trước đây đã bị như vậy lần nào chưa?

+ Có sử dụng thuốc gì chưa?

+ Tiền sử bệnh: Bệnh về tai, mũi, thói quen sinh hoạt, có ngoáy tai thường xuyên không?

Bác sĩ xác nhận dịch tai giữa và đánh giá màng nhĩ/thính lực; điều dưỡng nhận định nghe kém, ảnh hưởng giao tiếp/học tập. Thanh dịch không đồng nghĩa có mủ hoặc nhiễm trùng cấp.

## 2. Chẩn đoán điều dưỡng

Nghe kém/khó giao tiếp liên quan dịch tai giữa theo đánh giá; sốt cần tìm nguyên nhân khác hoặc bệnh phối hợp.

Khó chịu hoặc đau nếu có, cần đánh giá; không ghi mặc định đau do mủ.

2.3 Nguy cơ xảy ra biến chứng

2.4 Người bệnh thiếu kiến thức về bệnh

## 3. Lập kế hoạch chăm sóc

Đặt mục tiêu cá thể và thời điểm đánh giá: hô hấp/tuần hoàn ổn định, triệu chứng giảm so với ban đầu, dung nạp ăn/uống phù hợp, không xuất hiện dấu nguy hiểm, người

bệnh/người chăm sóc hiểu kế hoạch. Phân công người thực hiện và tần suất theo dõi theo nguy cơ/y lệnh.

## 4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

4.1. Theo dõi nghe kém và giao tiếp

Ghi ảnh hưởng nghe, ngôn ngữ, học tập và các yếu tố nguy cơ; hỗ trợ nói rõ, trực diện, giảm tiếng ồn.

- Hướng dẫn người bệnh uống thuốc theo y lệnh của BS

Bác sĩ chỉ định đánh giá thính lực và lịch theo dõi phù hợp; không tự dùng kháng sinh, steroid, kháng histamine hoặc thuốc co mạch để điều trị thanh dịch đơn thuần.

4.2 Giảm đau nhức tai cho người bệnh

Không hút mủ tai hoặc yêu cầu làm sạch mủ khi chưa có chảy mủ. Sốt/đau cấp cần bác sĩ đánh giá lại chẩn đoán.

- Uống thuốc theo y lệnh BS

4.3 Giảm nguy cơ xảy ra biến chứng

Theo dõi kéo dài, giảm nghe và ảnh hưởng phát triển; biến chứng/chỉ định can thiệp được bác sĩ đánh giá theo bệnh thực tế.

- Nên làm theo các hướng dẫn của BS đề đạt điều trị tốt nhất.

4.4 Giáo dục sức khỏe

Hướng dẫn diễn biến và lịch theo dõi; không đồng nhất thanh dịch với viêm tai giữa cấp.

Tái khám theo kế hoạch, sớm hơn khi sốt, đau, chảy dịch hoặc nghe kém tăng.

- Tuyên truyền phòng bệnh viêm tai giữa trong cộng đồng

- Không nên ngoáy tai thường xuyên.

## 5. Đánh giá

Đánh giá nghe/giao tiếp, triệu chứng và kết quả khám theo lịch; không lấy hết sốt/hết mủ làm tiêu chí mặc định.

- Người bệnh hiểu biết và cách phòng bệnh

Ghi kết quả theo từng mục tiêu, triệu chứng/sinh hiệu trước và sau, mức ăn uống và nhu cầu hỗ trợ; điều chỉnh kế hoạch khi chưa đạt hoặc có vấn đề mới. Không ghi chung “khỏe hơn” để thay giá trị theo dõi.

## Ghi chép bàn giao và hướng dẫn sau chăm sóc

Ghi nhận định, vấn đề, mục tiêu, thuốc/can thiệp, đáp ứng và thời điểm báo bác sĩ; bàn giao ISBAR, nơi và người tiếp nhận khi chuyển. Hướng dẫn đúng đơn, lịch tái khám cụ thể và dấu nguy hiểm; yêu cầu người chăm sóc nhắc lại. Không đợi hết thuốc khi có dấu xấu đi.

**Căn cứ và nội dung cần xác nhận**

Thông tư 31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956 . QĐ3023/QĐ-BYT dùng cho đề cương kỹ thuật khi có quy trình kỹ thuật riêng, không dùng để xác lập mọi can thiệp chăm sóc bệnh lý.

Nguồn chuyên môn tham khảo: https://www.entnet.org/resource/aao-hnsf-updated-cpg-ome-press-release-fact-sheet/. Áp dụng theo đối tượng và hoàn cảnh của hướng dẫn, không thay thế chỉ định bác sĩ hoặc quy định của bệnh viện.

Khoa TMH xác nhận chẩn đoán/mã ICD, danh mục kỹ thuật được phép, thuốc và kế hoạch theo dõi theo tuổi. Các chẩn đoán điều dưỡng trong nguồn là gợi ý, chỉ chọn khi có dữ liệu thực tế; không mặc định mọi người bệnh đều có tất cả vấn đề.

Người thẩm định/chữ ký/ngày: …… Số quyết định/ngày hiệu lực: ……